| TÍTULO: | | | Nº DOC: |
|---|---|---|---|
| Meta 1 – Identificação do Paciente | | | PRT.NSP.003 |
| **DATA 1ª VERSÃO** | **DATA DESTA VERSÃO** | **VERSÃO Nº** | **PRÓXIMA REVISÃO** |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 01 | 10/12/2027 |

## 1. OBJETIVO

O objetivo deste protocolo é garantir a correta identificação do paciente, a fim de reduzir a ocorrência de incidentes. Com o objetivo de identificar o paciente como a pessoa para a qual se destina o serviço ou tratamento e assegurar o devido serviço ou tratamento para o paciente certo.

## 2. ABRANGÊNCIA

O protocolo deverá ser aplicado em todos os ambientes de prestação do cuidado de saúde (unidades de internação, ambulatório, urgência, centro cirúrgico, quimioterapia, radioterapia, uti adulto e pediátrico, endoscopia...) em que sejam realizados procedimentos, quer terapêuticos, quer diagnósticos da FCECON.

## 3. RESPONSABILIDADES

**3.1 Recepção central:** Realizar a internação do paciente mediante a conferência dos dados junto ao documento de identificação com foto do paciente, cartão SUS e CPF, inseri-los no registro de documento de prontuário no sistema, preencher pulseira de identificação com os três identificadores (Nome completo, data de nascimento, nome completo da MÃE) e, colocá-la no membro superior direito do paciente. Esta deverá permanecer durante todo o período em que o paciente for submetido a algum tipo de procedimento/cuidado, no ambiente interno desta Unidade de Saúde, contemplada por este protocolo.

**3.2. Enfermeiro e equipe de enfermagem responsável pela admissão do paciente:** Realizar internação do paciente, o identificando por meio da pulseira de identificação contendo os indicadores: nome completo, data de nascimento, nome completo da mãe e, pela placa de identificação, beira-leito do paciente.

**3.3. Enfermeiro supervisor:** Supervisionar, na unidade, se todos os pacientes estão com a pulseira de identificação e se estão com informações legíveis; promover, junto aos acompanhantes, o projeto “Minuto do Acompanhante,” onde serão repassadas orientações para o melhor entendimento da permanência da pulseira de identificação até a alta.

**3.4. Equipe de enfermagem:** Na admissão, do paciente na unidade, verificar se está devidamente identificado com pulseira e preenchimento da placa de identificação beira leito. Durante a internação, manter a checagem da integridade da pulseira e dados dos pacientes. Caso a pulseira e a placa de identificação estejam ausentes, ou ilegíveis, providenciar, de imediato, a troca.

**3.5. Membros da equipe multidisciplinar:** Caso identifique o paciente sem a pulseira ou placa de identificação, comunicar ao enfermeiro assistencial para que providencie, imediatamente, a identificação.

**3.6. Serviço social:** Providenciar os dados de identificação de pacientes que chegam ao hospital sem documentos, ou dos que não verbalizam ou, são desorientados ou, não tenham acompanhantes que o identifique.

**3.7. Enfermeiro do núcleo de segurança do paciente:** Realizar a busca ativa, avaliar o número de eventos relacionados à falha na identificação do paciente, divulgar os resultados e desenvolver ações conjuntas com as áreas afins, promovendo a prevenção e diminuição de possíveis erros.

**3.8. Auxiliar administrativo:** Realizar o pedido de pulseiras para manutenção de estoque disponível no setor.

**3.9. Acompanhante:** Sinalizar a equipe de enfermagem, caso o paciente retire ou se ele, em algum momento da internação, estiver sem a pulseira. Conferir os dados que estão escritos na pulseira de identificação e sinalizar, caso haja algum dado não compatível a identificação do paciente.

## 4. MATERIAIS E RECURSOS

4.1 Para preenchimento manuscrito:

a. Pulseira branca de material resistente;

b. Placa de identificação do leito do paciente;

4.2. Para preenchimento eletrônico/ digital:

a. Impressora específica para impressão de pulseiras;

b. Pulseiras para impressão da identificação do paciente.

## 5. ETAPAS DO PROCESSO

### 5.1. Definições Institucionais

Na Fundação Centro de Controle de Oncologia (FCECON), o dispositivo padrão de identificação do paciente é a pulseira, sendo o **punho direito** o membro preferencial para sua colocação. Poderá ser realizado rodízio de membros, conforme avaliação clínica e necessidades individuais do paciente, considerando situações como presença de edema, amputações, dispositivos vasculares, alergias, lesões cutâneas ou outras condições que impeçam o uso seguro da pulseira no local preferencial.

A identificação institucional do paciente deverá conter três identificadores obrigatórios:

- **Nome completo do paciente;**
- **Nome completo da mãe;**
- **Data de nascimento do paciente.**

Nos casos em que a identidade do paciente não esteja disponível no momento da admissão e não haja informação do nome completo, poderão ser utilizados identificadores provisórios, tais como o número do prontuário e as características físicas mais relevantes do paciente, incluindo sexo e raça, devendo a identificação ser regularizada assim que possível.

Os identificadores do paciente poderão ser impressos de forma digital ou manuscritos. Independentemente do método adotado para produzir os identificadores, a informação deve: Ser fácil de ler, mesmo se a pulseira de identificação for exposta à água, sabão e detergentes, géis, sprays, produtos de limpeza a base de álcool, hemocomponentes e outros líquidos

corporais, e qualquer outro líquido ou preparação; e não se desgastar durante a permanência do paciente no hospital.

As etiquetas pré-impressas devem caber adequadamente no espaço da pulseira. Quando manuscritas, as informações deverão ser registradas em letras de forma. As pulseiras devem ser impermeáveis, seguras e invioláveis, sendo necessária verificação sistemática da legibilidade, especialmente após procedimentos e banho do paciente.

O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) da FCECON é responsável por promover a implantação, revisão e melhoria contínua dos processos relacionados à identificação segura do paciente, incluindo passagens de plantão, transferências e alta hospitalar.

### 5.2. Identificação do Paciente na Admissão

A identificação de todos os pacientes atendidos na FCECON, internados, em regime de hospital-dia, atendidos no serviço de emergência, ambulatórios, quimioterapia ou radioterapia, deverá ser realizada no momento da admissão, por meio da colocação da pulseira de identificação padronizada.

A pulseira deverá permanecer com o paciente durante todo o período em que estiver submetido ao cuidado. Caso a pulseira se desprenda, seja danificada ou torne-se ilegível, o paciente, familiar ou acompanhante deverá comunicar imediatamente a equipe de enfermagem para providenciar a substituição o mais breve possível, utilizando os serviços de internação e/ou admissão.

Para garantir a correta identificação, deverá ser utilizada pulseira branca padronizada contendo os três identificadores institucionais: nome completo do paciente, nome completo da mãe e data de nascimento. A pulseira deverá ser posicionada em membro visível, de modo a permitir sua conferência antes da realização de qualquer cuidado.

No momento da internação, o enfermeiro responsável deverá também realizar o preenchimento da placa de identificação (Anexo 1) localizado acima do leito, contendo as informações pertinentes ao paciente.

### 5.3. Confirmação da Identificação do Paciente Antes do Cuidado

A confirmação da identificação do paciente deverá ser realizada antes de qualquer cuidado, incluindo, mas não se limitando a:

- Administração de medicamentos;
- Administração de sangue e hemoderivados;
- Coleta de material para exames;
- Entrega de dietas;
- Realização de procedimentos invasivos.

O profissional responsável pelo cuidado deverá solicitar que o paciente, familiar ou acompanhante declare verbalmente (e, quando possível, soletre) o nome completo do paciente, o nome completo da mãe e a data de nascimento, conferindo essas informações com os dados contidos na pulseira de identificação e com o cuidado prescrito ou material a ser utilizado.

A identificação de hemocomponentes e hemoderivados deverá seguir rigorosamente a legislação específica vigente.

Mesmo que o profissional conheça o paciente, a verificação da identificação é obrigatória, com o objetivo de garantir que o paciente correto receba o cuidado correto. Essa verificação não deve ocorrer apenas no início do cuidado, devendo ser repetida a cada intervenção realizada durante a permanência do paciente na instituição.

É vedado:

- Realizar perguntas indutivas, como “Você é o Sr. Silva?”;
- Pressupor a identificação correta com base no leito, na placa de identificação ou no reconhecimento visual;
- Utilizar o número do quarto, enfermaria ou leito como identificador do paciente.

### 5.4. Transferência de Pacientes

Nas transferências internas ou externas, inclusive entre serviço de ambulância e unidade de saúde, deverão ser utilizados os três identificadores institucionais para garantir a exatidão da identificação. Quando nenhum dos identificadores estiver disponível, deverão ser registrados o maior número possível de informações, tais como:

- Local e horário do resgate;
- Número de registro do atendimento do serviço de transporte;
- Descrição física do paciente.

Essas informações deverão constar em todos os documentos relevantes e no prontuário do paciente, até que a identificação formal seja estabelecida.

IMPORTANTE: O número do quarto/enfermaria/leito do paciente não pode ser usado como um identificador, em função do risco de trocas no decorrer da estada do paciente no serviço.

### 5.5. Placas de identificação e Riscos Assistenciais

As placas de identificação do paciente (Anexo 1) deverão ser confeccionadas pelo enfermeiro na admissão do paciente com os indicadores padronizados neste protocolo. Os riscos assistenciais dos pacientes internados deverão ser sinalizados na placa do leito, de forma manual, após avaliação específica de cada risco. Devem estar sinalizados, minimamente, os riscos de alergia, flebite, lesão por pressão, queda, broncoaspiração e outros riscos identificados durante a avaliação clínica.

### 5.6. Identificação com Uso de Abreviatura

A abreviatura do nome do paciente é permitida exclusivamente para a confecção de rótulos de soro e etiquetas de identificação de soluções, nos casos de pacientes com nomes compostos por cinco ou mais nomes, mantendo-se a grafia completa do primeiro, do segundo e dos dois últimos nomes.

### 5.7. Identificação com Uso de Nome Social

Nos casos de pacientes que possuam nome social, o registro deverá ser realizado mediante solicitação do próprio interessado, constando na pulseira de identificação:

- Nome social (em destaque);
- Nome civil;
- Data de nascimento;
- BE.

O nome social deverá constar nos sistemas de informação, cadastros, formulários, fichas e prontuários, em campo específico, mantendo o nome civil apenas para fins administrativos internos. A conferência deverá ser realizada verbalmente pelo nome social e documentalmente pelo nome civil, conforme prescrição e prontuário.

### 5.8. Identificação de Pacientes Homônimos ou com Nomes Semelhantes

Pacientes homônimos ou, com nomes semelhantes, quando internados na mesma unidade assistencial, devem ser alocados pelo NIR, com a sinalização do enfermeiro, em enfermarias diferentes (barreira física). Se não for possível, diante da limitação de disponibilidade de leitos, estes devem ser assistidos por equipes assistenciais distintas, principalmente, no tocante aos técnicos de enfermagem (barreira técnica), até que seja possível realizar o devido remanejamento.

OBSERVAÇÃO: No caso de nomes homônimos, na mesma unidade de internação, deverá ser acrescentado à pulseira e ao prontuário uma etiqueta vermelha com a palavra "HOMÔNIMO"

### 5.9. Identificação do corpo (óbito)

Após o preparo do corpo, o técnico de enfermagem imprime e preenche a etiqueta de identificação do óbito (Anexo 3), em duas vias, e fixa uma, sobre o tórax do paciente e, a outra na capa mortuária. O técnico de enfermagem deve encaminhar o corpo em uma maca até o necrotério. No necrotério, o técnico de enfermagem deverá preencher todos os dados no livro de registro, de entrada e saída de corpo, que se encontra no local.

### 5.10. Identificação de peças anatômicas

A equipe de enfermagem deve identificar as peças anatômicas em etiquetas padronizada contendo nome completo, data de nascimento, nome da mãe e característica da peça, antes de sair da sala cirúrgica.

### 5.11. Observações Importantes Quanto À Identificação Do Paciente

- Nos casos de pacientes impossibilitados de verbalizar (ex.: comatosos, sedados ou com rebaixamento do nível de consciência), a conferência da identificação deverá ser realizada por meio da pulseira e do prontuário.
- Impossibilidade de colocação de pulseira por queimadura, amputação, alergia, outras lesões de pele e/ou recusa por parte do paciente ou acompanhantes: os dados para identificação devem ser colocados em placa de identificação (Anexo 2), nos pés da cama, que acompanhará o paciente em qualquer situação de transporte ou

transferência de setor. Neste caso, orientar paciente e acompanhante sobre o uso da placa de identificação e registrar em prontuário.

- Obesidade ou edema generalizado: acoplar 2 pulseiras ou mais para abranger a circunferência do membro superior ou inferior.
- Caso o paciente recuse todas as formas de identificação, deverá ser esclarecido que, embora seja um direito, o cumprimento da política institucional é essencial para sua segurança. O atendimento deverá ser mantido, e a recusa registrada em prontuário.
- No centro cirúrgico, quando houver necessidade de retirada da pulseira durante o procedimento, uma nova pulseira deverá ser colocada antes da saída do paciente do setor.
- A pulseira de identificação e o local de sua colocação deverão ser avaliados diariamente, a fim de detectar falhas de legibilidade ou potenciais danos locais.

## 6. ORIENTAÇÕES AOS PACIENTES / CLIENTES

O paciente, familiar, acompanhante ou cuidador deverá ser orientado quanto:

- à finalidade da pulseira de identificação;
- ao significado dos três identificadores institucionais;
- à obrigatoriedade da conferência da identificação antes da realização de cuidados;
- à importância da manutenção do quadro de identificação corretamente preenchido acima do leito.

Essa orientação visa estimular a participação ativa do paciente e familiares no processo de identificação segura e na prevenção de incidentes assistenciais.

## 7. RISCOS RELACIONADOS E AÇÕES PREVENTIVAS

O processo de identificação do paciente apresenta riscos assistenciais que podem ocorrer em todas as etapas do cuidado, desde a admissão até a alta hospitalar. Falhas nesse processo podem resultar em eventos adversos graves, como administração incorreta de medicamentos, realização de procedimentos em paciente errado, trocas de exames, dietas

inadequadas e erros em transfusões de sangue e hemoderivados. Principais riscos relacionados:

- Ausência, troca ou ilegibilidade da pulseira de identificação;
- Utilização de identificadores incompletos, incorretos ou abreviados;
- Não conferência ativa da identificação antes dos cuidados;
- Pacientes com alteração do nível de consciência, sedados, confusos ou impossibilitados de verbalizar;
- Homonímia (nomes iguais ou semelhantes);
- Mudança de leito, setor ou transferência entre serviços;
- Falhas na comunicação entre equipes assistenciais;
- Retirada da pulseira durante procedimentos sem reposição imediata.

Ações preventivas

- Utilização obrigatória dos três identificadores institucionais (nome completo do paciente, nome completo da mãe e data de nascimento) em todos os pontos de cuidado;
- Conferência ativa da identificação do paciente antes de qualquer procedimento assistencial, exame, administração de medicamentos, dietas, sangue ou hemoderivados;
- Verificação sistemática da integridade e legibilidade da pulseira de identificação, com substituição imediata quando necessário;
- Educação contínua dos profissionais de saúde quanto à importância da identificação correta do paciente;
- Orientação aos pacientes e acompanhantes para que colaborem com o processo de identificação;
- Adoção de medidas adicionais de segurança para pacientes homônimos;
- Registro adequado em prontuário nas situações excepcionais (pacientes não identificados, recusas, impossibilidade de uso da pulseira);
- Monitoramento contínuo do processo pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), com revisão periódica de fluxos e protocolos;

- Notificação de incidentes e quase falhas relacionados à identificação do paciente, visando análise e implementação de melhorias.

Essas ações funcionam como barreiras de segurança essenciais para reduzir a ocorrência de eventos adversos, fortalecer a cultura de segurança e garantir a qualidade da assistência prestada na FCECON.

## 8. INDICADORES - ESTRATÉGIAS DE MONITORAMENTO

Todos os incidentes envolvendo identificação incorreta do paciente devem ser notificados de acordo com a legislação vigente e investigados pelo serviço.

As implementações das recomendações geradas pelas investigações devem ser monitoradas pelo próprio serviço de saúde.

### 8.1. Indicadores

**8.1.1.** Número de eventos adversos devido a falhas na identificação do paciente.

**8.1.2.** Proporção de pacientes com pulseiras padronizadas ou identificação no leito, entre os pacientes internados

Será utilizada a Taxa de identificação do paciente com objetivo de monitorar o cumprimento do Protocolo de Identificação do Paciente.

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Número de pacientes com identificação* x 100}}{\text{Número de pacientes internados}}$$

* pulseira com informações completas e legíveis

Verificação mensal (uma vez ao mês, em data aleatória), setorialmente.

## 9. REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Saúde. Anexo 02: Protocolo de Identificação do Paciente. Brasília: Anvisa, 2013. Disponível em: <https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/identifica.

CONSÓRCIO BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO; JOINT COMMISSION INTERNATIONAL. Padrões de Acreditação da Joint Commission Internacional para Hospitais. 4ª ed. [editado por] Consórcio Brasileiro de Acreditação de Sistemas e Serviços de Saúde. Rio de Janeiro: CBA, 2011

## 10. ANEXOS

### ANEXO 1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Foto: Dispositivo móvel



## ANEXO 2 - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE DA FCECON.




Foto: Dispositivo móvel

## ANEXO 3 - MODELO PADRONIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DO CORPO.

Unidade de origem:_____

Nome completo (sem abreviações): _____

Data de Nascimento: ___/___/____

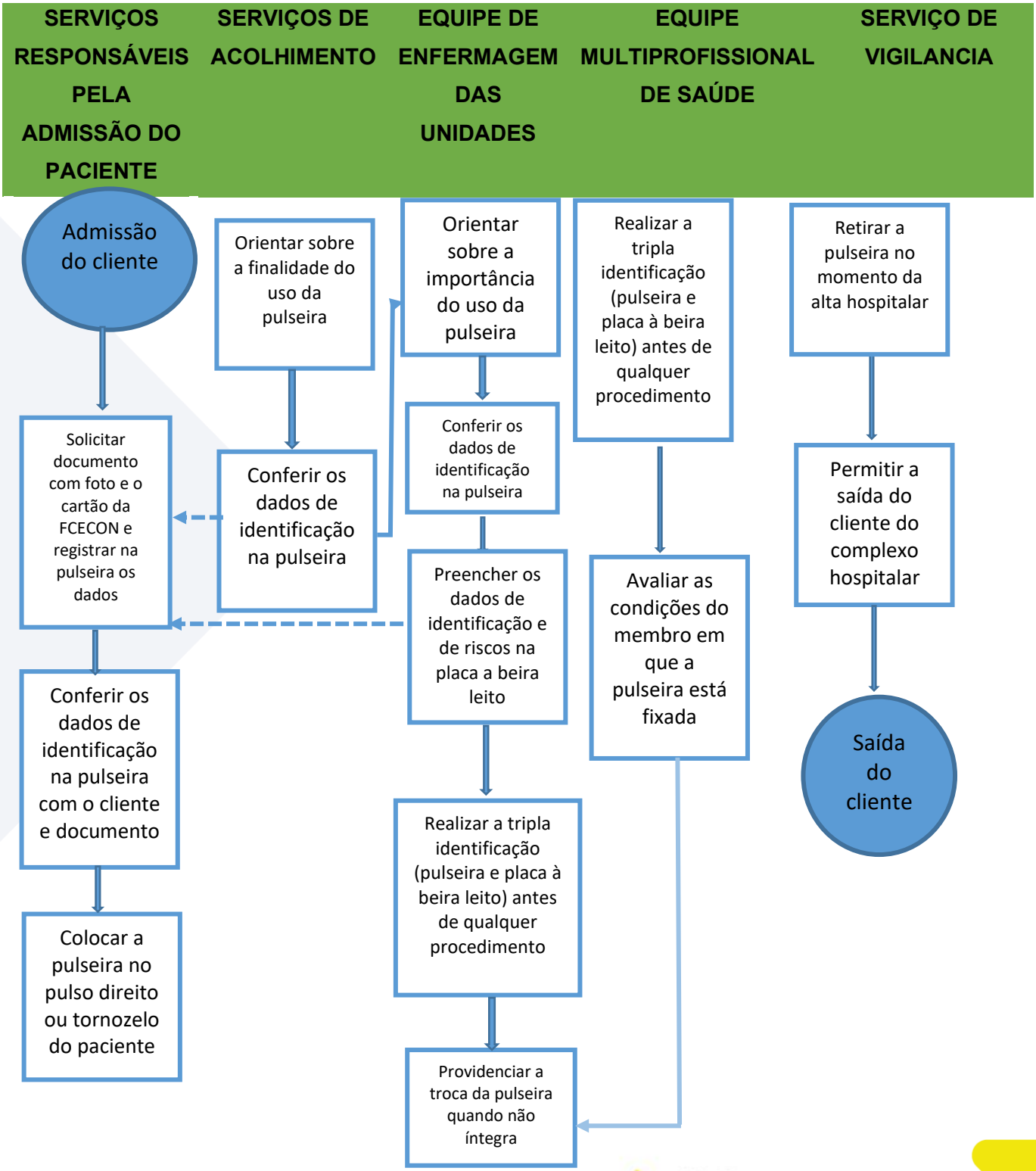
Nome da Mãe:_____

Data e hora do óbito: ___/___/____ as ___:___h

Corpo sem identificação(registrar cicatrizes, tatuagens, características físicas):

_____

## ANEXO 4 - FLUXO / CONDUTA PADRONIZADA NA INSTITUIÇÃO.



## 11. HISTÓRICO DE REVISÃO

| VERSÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | 10/12/2025 | Elaboração do Protocolo da Meta 1 – Identificação do Paciente |

| | |
|---|---|
| **Elaboração:**<br><br>ANDREA LIMA DE SOUZA MARQUES:49400991215<br>Assinado de forma digital por ANDREA LIMA DE SOUZA MARQUES:49400991215 Dados: 2025.12.18 07:33:47 -04'00'<br>**Coordenação do Núcleo de Segurança do Paciente**<br>Andréa Lima de Souza Marques | **Data:** 10/12/2025 |
| **Revisão:**<br><br>GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA:68376006215<br>Assinado de forma digital por GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA:68376006215 Dados: 2025.12.23 12:46:29 -04'00' | **Data:** |
| **Aprovação:**<br><br>HILKA FLAVIA BARRA DO ESPIRITO SANTO ALVES PEREIRA:31006337253<br>Assinado de forma digital por HILKA FLAVIA BARRA DO ESPIRITO SANTO ALVES PEREIRA:31006337253 | **Data:** |